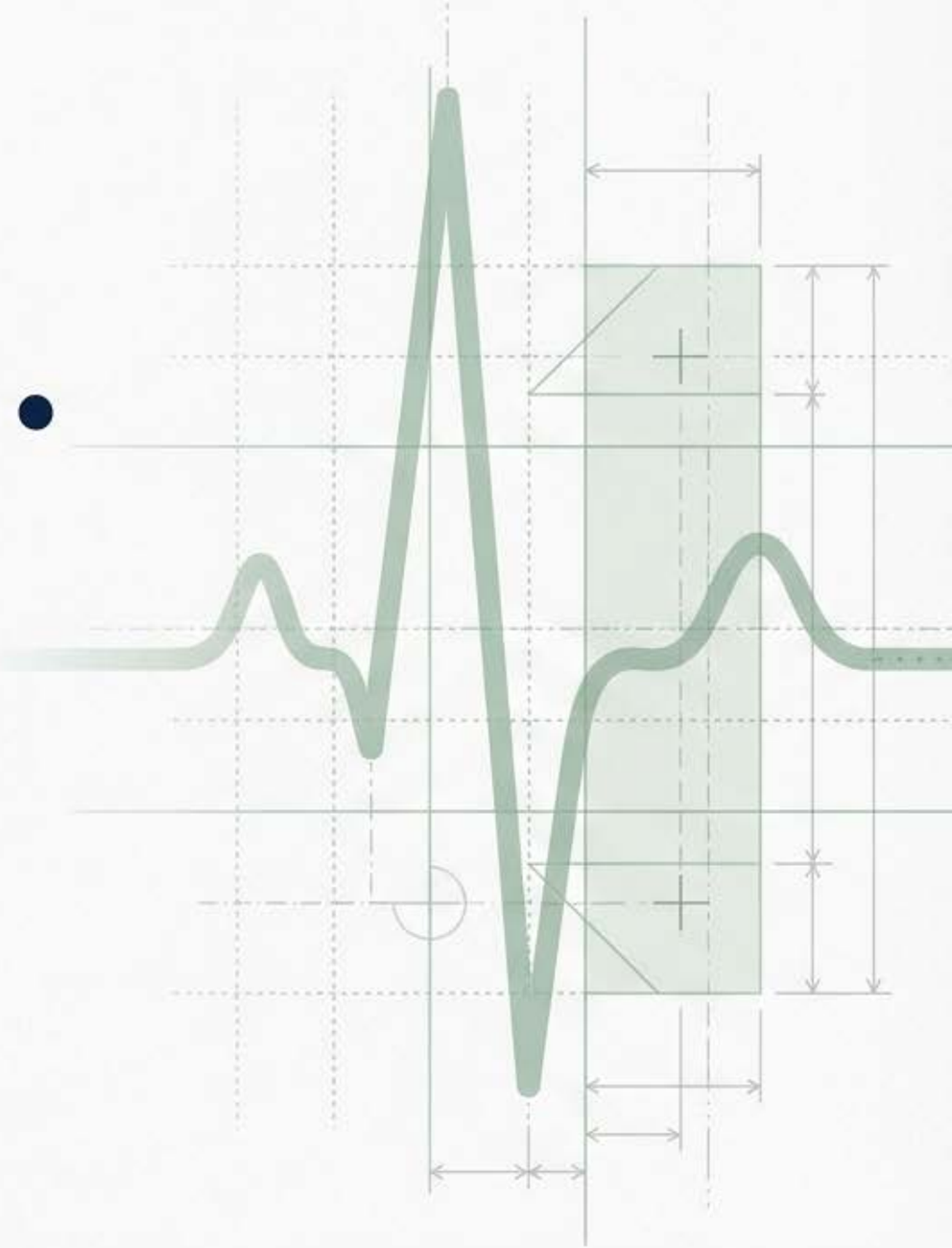
# 松尾氏 BCPコンテンツ・マネタイズ事業計画書

## 18年の急性期臨床経験を「事業継続」の価値へ変換するロードマップ



NotebookLM

# 「机上の空論」を「命を救う行動」へ

## 現状：過酷な夜勤（月4回）

- 課題：体力的な限界

## 目標：副業収入 月20万〜30万円

- 制約：稼働上限は「1日2時間」
- 戦略：モジュラー型ビジネスモデル

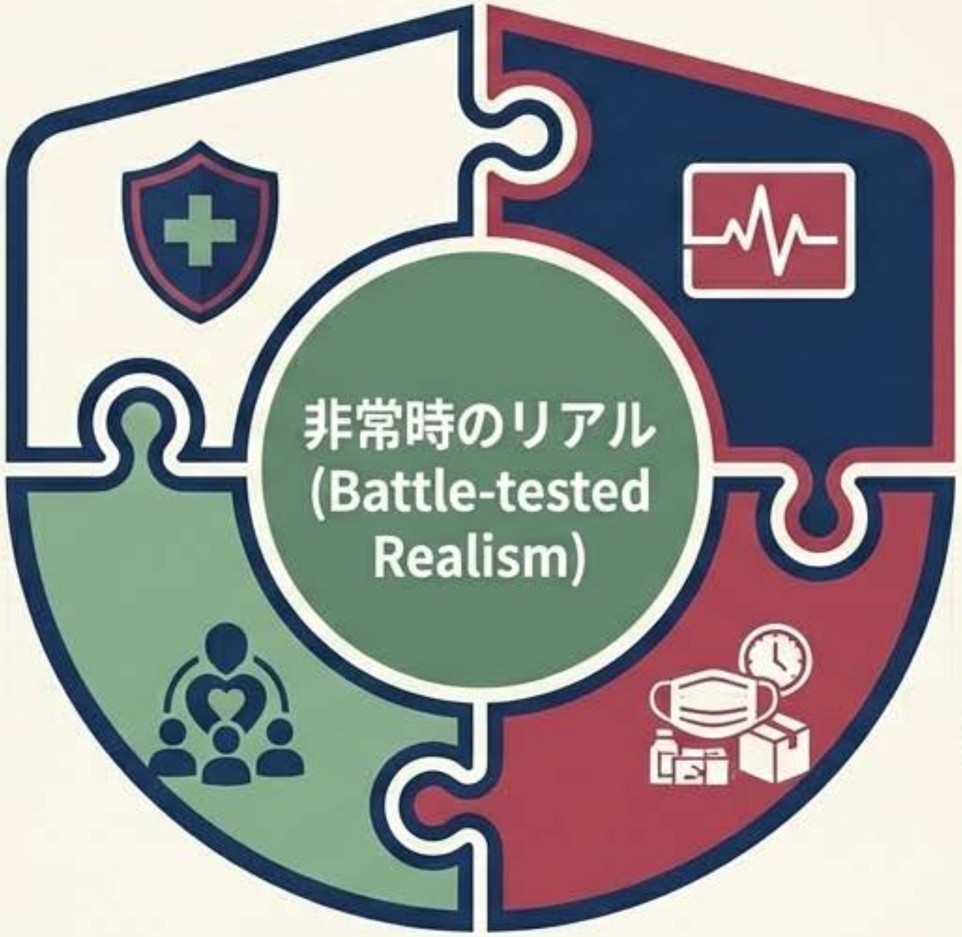
**18年の急性期臨床経験とBCPを融合し、福祉法人・自治体向けの超実践的な緊急対応コンテンツを創出する。**

NotebookLM

# 圧倒的優位性：Founder-Market Fit

**看護師18年の経験**
（急性期の判断力）

**心電図検定1級**
（高度なデータ分析）




**ACLSインストラクター**
（チーム統率と教育）

**コロナ禍30日泊まり込み**
（人員・物資不足のサバイバル）

これらは机上のコンサルタントには絶対に模倣できない最大の堀（Moat）である。

NotebookLM

# 市場の切迫感：2024/2025年 BCP完全義務化

**2024年4月: BCP策定・研修・訓練の義務化開始**

**2025年4月: 経過措置終了**

**ペナルティ：基本報酬の1%〜3%減算**
**(業務継続計画未策定減算)**

感染症BCP 未完了率 **70.5%**

自然災害BCP 未完了率 **73.0%**

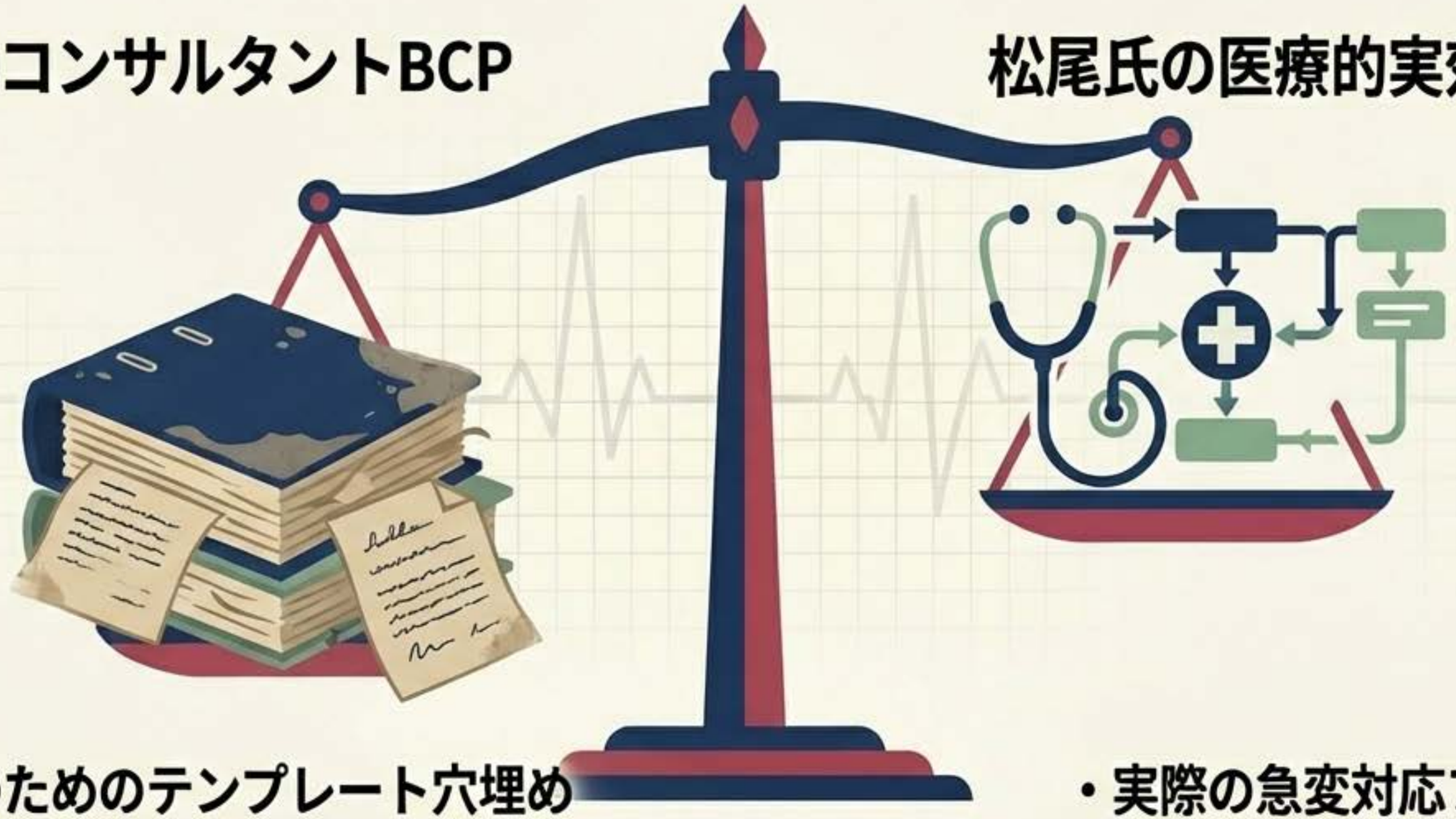
**厚労省調査：未だ多くが未策定、または実効性に不安を抱えている現実。**

NotebookLM

# 市場の致命的なギャップ：「書類上のBCP」

## 従来のコンサルタントBCP

- 減算回避のためのテンプレート穴埋め
- 医療視点の完全な欠如
- 結果：いざという時に全く動けないマニュアル



## 松尾氏の医療的実効性BCP

- 実際の急変対応フロー
- 外部医療機関との的確な連携
- リアルなトリアージ機能

NotebookLM

# 解決策：「ISO/厚労省ガイドライン」の現場翻訳

ISO 31000 / ISO 22301
難解な厚労省ガイドライン
in Noto Sans JP Bold
Yu Gothic Medium

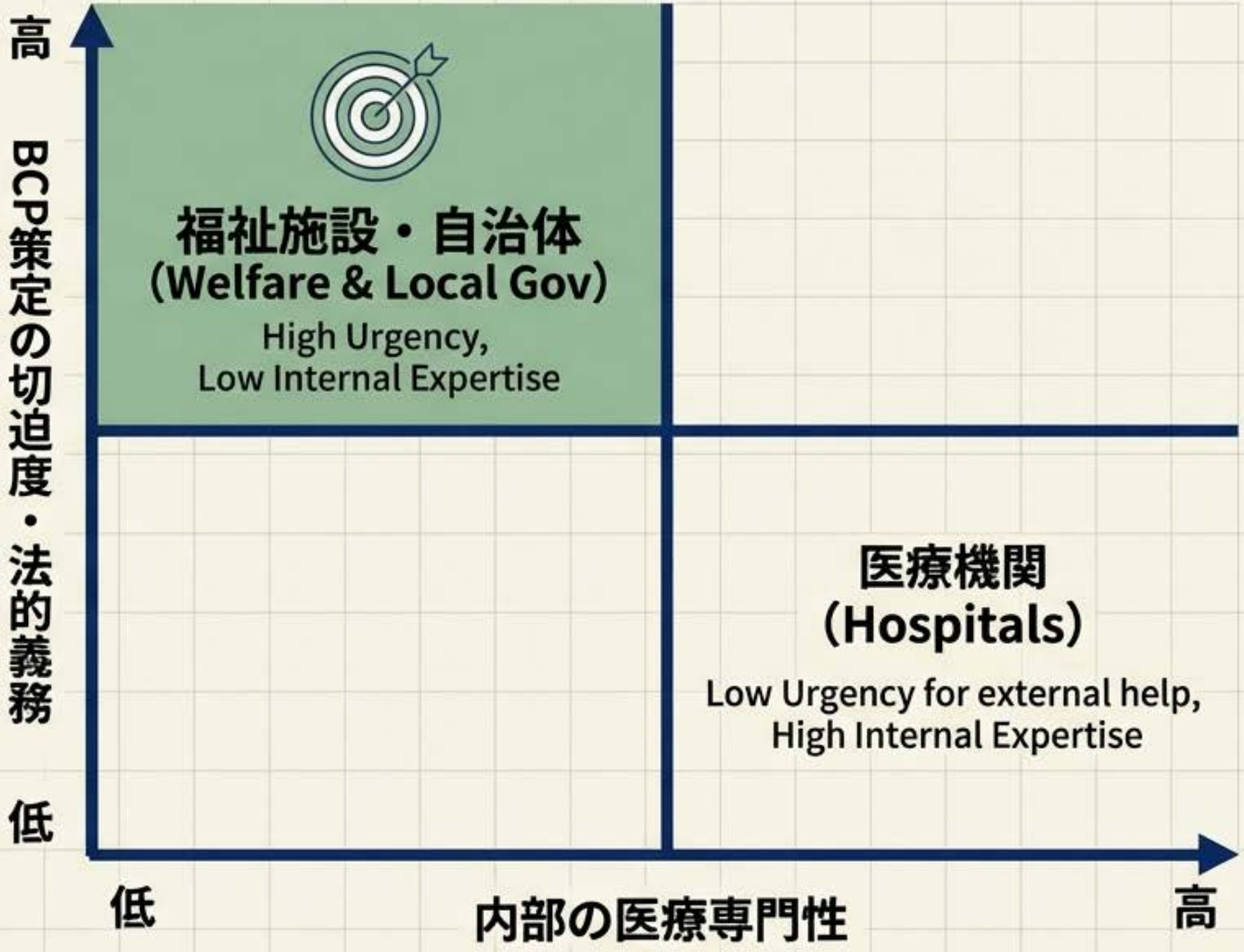
松尾氏
(翻訳者 / Clinical Filter)

生理学的知識とトリアージ感覚を
用いた優先業務の定義
Yu Gothic Medium

現場の介護職が直感的に
動ける実践フロー
Noto Sans JP Bold

NotebookLM

# ターゲット戦略：なぜ「福祉・自治体」を狙うのか？




**内部に医療知見を持たない福祉・自治体こそが、外部からの「医療知見の注入」に最も高い価値（Willingness to Pay）を感じる。**

自治体BCP策定状況（6要素追跡データ）

NotebookLM

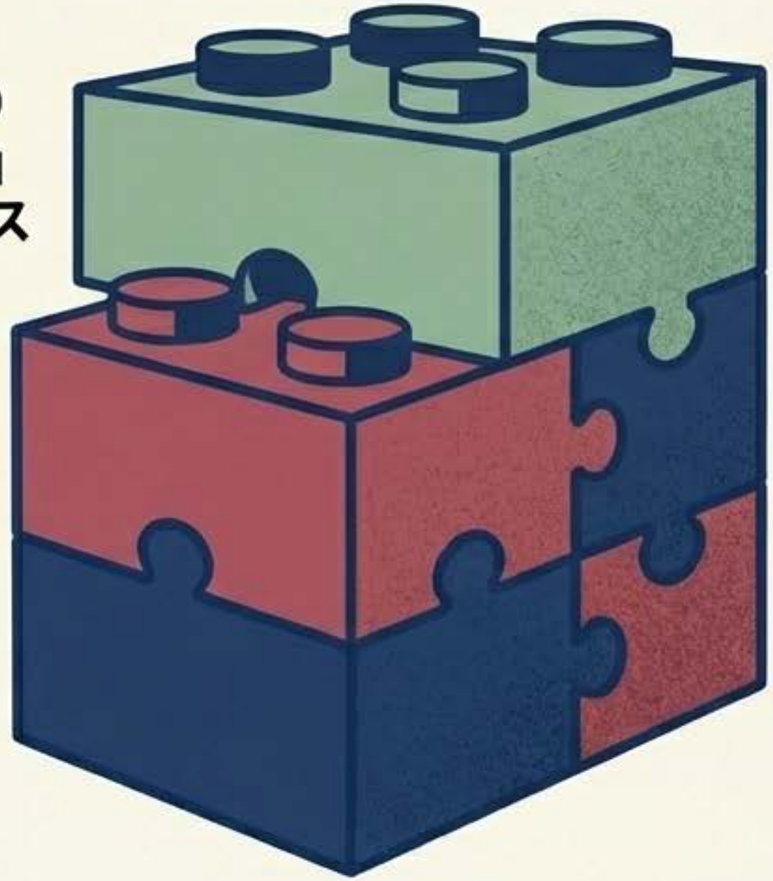
# プロダクト展開：「1日2時間」の制約を打破するモジュラー設計

リソース上限：1日2時間

既存BCPの
「医療的実効性」
簡易添削・監査サービス

義務化対応向け
職員研修用マイクロ
ビデオスクリプト

感染症・災害時の
初動アクションカード
＆チェックリスト

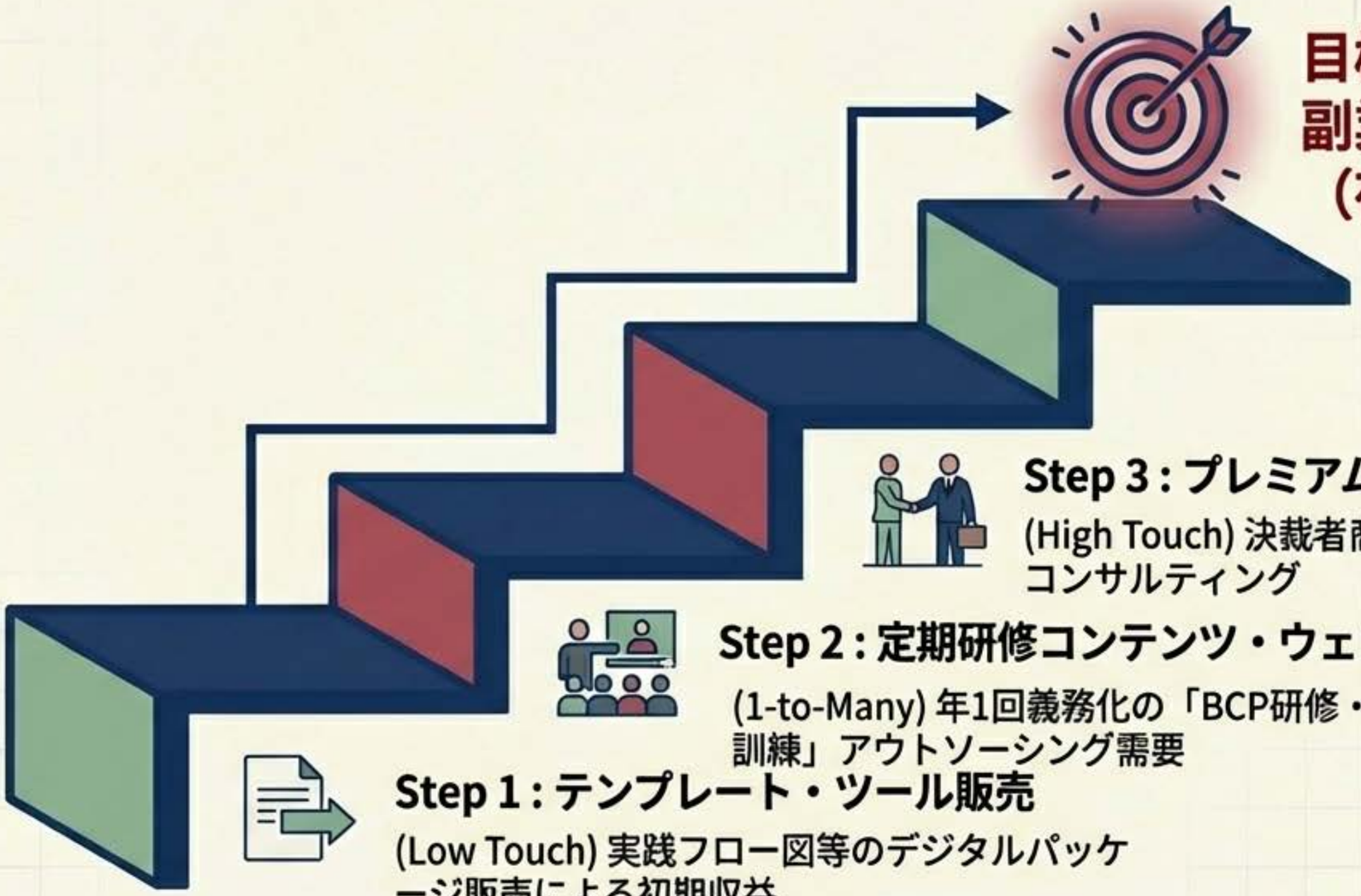


**スケーラブルな包括的
BCPツールキットの完成**

大規模コンサルではなく、検証・量産
可能なミニ版コンテンツから展開。

NotebookLM

# マネタイズ・モデル：3段階の収益化ステップ



**目標達成：**
**副業月収30万円**
**（夜勤ゼロへ）**

**Step 3 : プレミアム顧問・レビュー**

(High Touch) 決裁者商談による地域密着型コンサルティング

**Step 2 : 定期研修コンテンツ・ウェビナー**

(1-to-Many) 年1回義務化の「BCP研修・訓練」アウトソーシング需要

**Step 1 : テンプレート・ツール販売**

(Low Touch) 実践フロー図等のデジタルパッケージ販売による初期収益

NotebookLM

# 権威性の構築：臨床知見 × 国際標準規格

**18年の臨床経験**

ACLSのトリアージ基準
心電図検定のデータ分析

＋

**グローバル
スタンダード**

ISO 31000 (リスクマネジメント)
ISO 22301（事業継続)

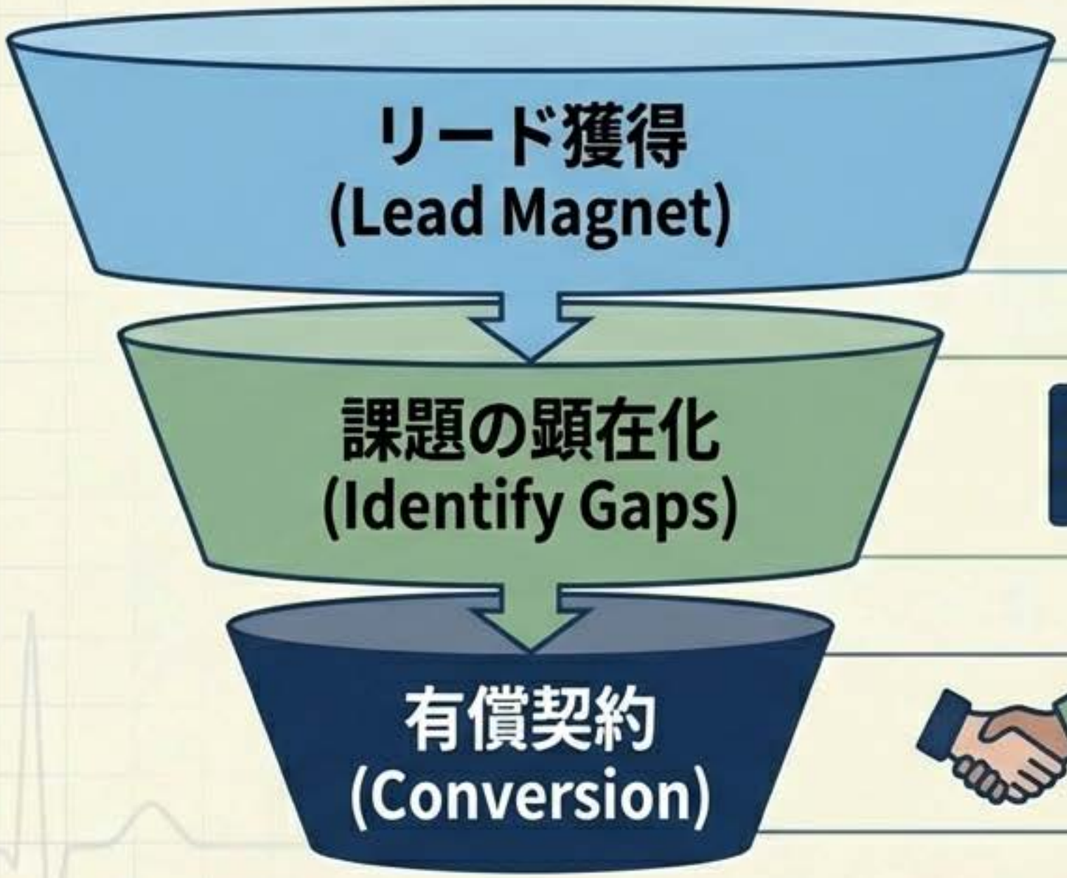
＝

**B2Bの絶対的な
信頼と権威性**

法人決裁者（施設長・
自治体幹部）からの承認

NotebookLM

# GTM・セールス戦略：リード獲得から成約まで




施設管理者向け「無料BCP医療的実効性・簡易監査（チェックリスト）」の配布

「自施設のBCPには医療視点がゼロだ」という気付きを提供

ミニコンテンツパッケージ販売 &
必須研修・顧問契約への移行

**課題**：法人案件は時間がかかる。
**解決策**：無料オファーからの段階的アプローチ。

NotebookLM

# 実行ロードマップ：月収30万・夜勤ゼロへの道

**0-6ヶ月: 検証＆ミニコンテンツ作成**

- 厚労省ひな形の分析
- アクションカードプロトタイプ作成
- 無料モニターによるテスト

**6-12ヶ月: セミナー・パッケージ販売**

- 研修義務化に向けたウェビナー
- デジタルコンテンツ収益化開始

**1-2年: プレミアムコンサルへの移行**

- 成功事例を基にした高単価商談

**目標達成：月収20〜30万円 ＆ 夜勤からの完全離脱**

NotebookLM

# Next Actions：明日から着手すべき3つのタスク

- [ ] 厚労省「介護施設向けBCPひな形」をダウンロードし、医療専門職の視点で抜け漏れを**赤字**でリストアップする。
- [ ] 毎日のスケジュールに「1日2時間」のコンテンツ作成ブロックを確保する。
- [ ] 最初のプロトタイプとなる「感染症発生時の初動アクションカード」の骨子を書き出す。

NotebookLM